

Neutralność *realistyczny cel*

Alternatywa dla body positivity. **NIE** wymaga „kochaj ciało” — wystarczy neutralność. Ciało jako funkcja, nie estetyka. Wood-Barcalow 2010 — naturalna postawa zdrowego obrazu ciała.

CZAS: 25 min · zmiana paradygmatu Etap 3-4 CBT-E (sesje 14-20)

ŹRÓDŁO: Wood-Barcalow i in. (2010); Cook-Cottone (2015)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **trzy postawy** wobec ciała (sekcja 1), **sześć elementów body neutrality** (sekcja 2). Sekcja 3 — praca z funkcją ciała. Sekcja 4 — wdzięczność, nie „kochaj”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Body neutrality to **postawa środkowa** między „body negativity” (nienawiść do ciała, typowa dla bulimii) a „body positivity” (przymus „kochania ciała”, często *nieautentyczny*). Postawa neutralności: „*moje ciało jest — robi rzeczy — nie musi być piękne ani kochane*”. Wood-Barcalow i in. (2010): *body positivity* dla wielu jest *niedostępna* — dodaje wstydu. Body neutrality to **bardziej realistyczny cel**. Cook-Cottone (2015): ciało jako **dom**, nie *obiekt*. Praktyka: fokus na **funkcję** (co *robi*), nie wygląd. Tylka & Wood-Barcalow (2015): pacjenci osiągający neutralność mają **znacząco wyższą** jakość życia niż walczący o pozytywność.

01 = Trzy postawy wobec ciała

BODY NEGATIVITY

„*Moje ciało jest złe, ohydne, do naprawy*”. Typowa dla bulimii. Wstyd, walka, kompensacje, ukrywanie.

BODY NEUTRALITY

„*Moje ciało jest. Robi rzeczy*”. Bez walki, bez przymusu miłości. Funkcja > estetyka. **Realistyczny cel.**

BODY POSITIVITY

„*Kocham swoje ciało*”. Dla wielu pacjentów *nieautentyczne*, dodaje wstydu („*nie umiem kochać*”). Wysoka poprzeczka.

Klucz: body positivity jest *doskonałym celem* — dla osób, które już mają zdrową relację z ciałem. Dla osób z bulimią to często za *wysoka poprzeczka*, która generuje frustrację („*nie umiem nawet tego*”). Body neutrality jest *krokiem pośrednim* — bardziej dostępnym, ale dającym większą wolność od zaburzenia.

02 = Sześć elementów body neutrality

1 · NIE MUSISZ KOCHAĆ

Body neutrality *nie* wymaga miłości. Wymaga *zaprzestania walki*. To znacznie mniej.

2 · AKCEPTACJA WYSTARCZY

„*Moje ciało takie jest dziś*”. Bez ocen, bez planów zmiany. *Jest*.

3 · FOKUS NA FUNKCJĘ

Ciało *chodzi, oddycha, czuje, dotyka, słyszy, smakuje*. To są fakty. Funkcja jest *realna*, niezależna od wyglądu.

4 · WDZIĘCZNOŚĆ ZA DZIAŁANIE

Nie za wygląd — za to, *co ciało robi*: niesie, leczy, regeneruje, daje doznania. Wdzięczność funkcjonalna.

5 · CIAŁO JAKO DOM

Cook-Cottone (2015): ciało *nie* jest obiektem estetycznym, jest *domem*. Mieszkasz w nim. Dbasz, ale nie oceniasz.

6 · BARDZIEJ DOSTĘPNE

Neutralność wymaga *mniej* niż pozytywność. Realistyczny cel terapii. Może być punktem wyjścia do body positivity później.

03 \ Moja praca z funkcją ciała

Zauważ **co Twoje ciało robi** w ciągu dnia. Nie jak wygląda — co *robi*. Funkcjonalność jest *realna*, niezależna od oceny estetycznej.

CO MOJE CIAŁO ZROBIŁO DLA MNIE WCZORAJ

— *chodzenie, niesienie rzeczy, oddychanie, sen, regeneracja*

CO MOJE CIAŁO UMIE

— *umiejętności fizyczne, doznania zmysłowe, regeneracja*

04 Wdzięczność, nie „kochaj”

Body positivity: „Kocham swój brzuch” → dla wielu nieautentyczne, dodaje wstydu.

Body neutrality: „Mój brzuch jest. Dziękuję mu za trawienie, za noszenie organów, za bycie częścią mnie” → realistyczne, dostępne, wystarczające.

Wdzięczność funkcjonalna *nie* wymaga zmiany uczuć estetycznych — wymaga zauważenia, *co* ciało robi. To poznawczy *fakt*, nie emocja. Można praktykować codziennie — krótka chwila po obudzeniu lub przed snem.

Klucz: body neutrality jest *uwalniająca*, ponieważ nie wymaga zmiany uczuć estetycznych. Można *nie lubić* swojego brzucha i jednocześnie *nie walczyć* z nim. To dwie różne rzeczy. Wood-Barcalow i in. (2010): badania *positive body image* ujawniły, że osoby zdrowo funkcjonujące w swoim ciele **nie** deklarują „kocham swoje ciało” — deklarują *akceptację* i *wdzięczność funkcjonalną*. Tylka & Wood-Barcalow (2015): w dużym badaniu populacyjnym body neutrality korelowała z **wyższą** jakością życia niż body positivity — bo była bardziej *autentyczna* i mniej wymagająca. Cook-Cottone (2015) w *psychobiosocjal model*: ciało jako *dom* to przesunięcie z myślenia *obiektywnego* na *relacyjne*. Dom to coś, w czym *mieszkasz*, dbasz o niego, czasem narzekasz na niedoskonałości, ale nie planujesz go *burzyć*. To metafora terapeutycznie wartościowa, bo wprowadza *spokój* tam, gdzie była *walka*. Solomon (2018) w ruchu *body neutrality*: „*twoje ciało nie jest projektem — jest miejscem, w którym żyjesz*”. Pacjenci często odczuwają **znaczącą ulgę**, gdy odkrywają, że nie muszą „*polubić*” siebie — wystarczy *nie walczyć*.